

**Composition:**

Capsules: Each DOLOSCOP Capsule contains:

Hyoscine-N-Butylbromide 10 mg and Paracetamol 400 mg.

Suppositories: Each DOLOSCOP Suppository contains:

Hyoscine-N-Butylbromide 10 mg and Paracetamol 500 mg.

Mechanism of Action:

Hyoscine-N-Butylbromide has an antispasmodic action on smooth muscles of the gastrointestinal tract, biliary tract and urogenital tract. Peripheral anti-cholinergic effects are due to ganglion blocking within the visceral wall and to antimuscarinic effects.

Paracetamol is an effective analgesic and antipyretic. It works by inhibiting the synthesis of prostaglandins in the central nervous system and to a lesser extent through a peripheral effect by blocking the generation of pain impulses.

Pharmacokinetics:

Hyoscine-N-Butylbromide: Is a quaternary ammonium compound, it is highly polar and hence only partially absorbed following oral (8%) or rectal (3%) administration. Its peak plasma concentration maximum within 0.25 - 2 hours. Plasma protein binding (albumin) is approximately 4.4%. It is metabolized mainly via the hydrolytic portion of the ester bond, excreted in faeces and urine.

Paracetamol: Paracetamol is rapidly and almost completely absorbed in the small intestine. After oral administration, the maximum concentration in plasma is reached after oral administration 0.5-2 hours.

After rectal administration, Paracetamol is absorbed, giving 30 to 40% bioavailability. The maximum concentration in plasma is reached after administration of 1.3-3.5 hours. Paracetamol diffuses rapidly into all tissues. The binding to plasma proteins is low between (5-20%). Paracetamol is mainly metabolized in the liver and is half-life of its elimination is approximately two hours.

Indications:

DOLOSCOP is indicated for patients who suffer from spasms of the gastrointestinal tract, biliary tract, and urogenital tracts (such as female dysmenorrhea).

Contraindications:

- Hypersensitivity to the active ingredients or to any of the components of the product.
- Mechanical narrowing of the gastrointestinal tract.
- Megacolon.
- Urinary retention with sub-bladder obstruction (such as a prostate adenoma).
- Narrow angle glaucoma.
- Tachycardia.
- Myasthenia gravis.

Warnings & Precautions:

- If severe abdominal pain persists or worsens or is accompanied by other symptoms such as fever, nausea, vomiting, changes in bowel motility, low blood pressure, fainting, or blood in the stool, a doctor should be consulted immediately.

- DOLOSCOP should be used with caution in patients with:

- Hepatic dysfunction (due to chronic alcohol abuse or hepatitis).
- Deficiency of the enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase.
- Blood counts, hepatic and renal function should be monitored with prolonged use.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: There are no adequate data on the use of DOLOSCOP during pregnancy. You should not take DOLOSCOP without consulting the doctor.

Lactation: For Hyoscine-N-Butylbromide, the safety of its use during lactation has not been established. However, no harmful effects on a nursing infant have been reported. Paracetamol enters breast milk, but is not likely to affect the infant when therapeutic doses are used.

Driving & Using Machines:

No studies have been performed on the effects on the ability to drive or use machines. Caution should be exercised in patients with visual disturbances.

Drug Interactions:

- Concomitant use with anticholinergics, amantadine, tricyclic and tetracyclic antidepressants, neuroleptics, quinidine, antihistamines, disopyramide, as well as the tachycardic effect of β -sympathomimetics, may increase the anticholinergic effects.
- Concomitant use with dopamine antagonists such as metoclopramide can lead to a combined weakening of the effect on the motility of the gastrointestinal tract.
- Concomitant use with probenecid leads to decreased clearance of Paracetamol, therefore the dose of Paracetamol should be reduced.
- Concomitant and prolonged use with anticoagulants such as warfarin and other coumarins may enhance the anticoagulant effect and thus increase the risk of bleeding.
- Caution should be exercised with concomitant use with flucloxacillin due to the possibility of metabolic acidosis.

Side Effects:

Many of the known undesirable effects are due to the anticholinergic properties of Hyoscine-N-Butylbromide. These anticholinergic effects are generally mild, such as: dizziness, fatigue, mouth dryness (inhibition of salivary secretion), diarrhea, nausea, vomiting, stomach upset, shortness of breath.

Rare: hypotension, flushing of the skin, irregular heartbeat, urinary retention.

Dosage & Administration:**Capsules:**

- Adults: One or two capsules, three times a day.
- The total daily dose should not exceed 6 capsules.
- The capsules should not be chewed, but should be swallowed whole with a sufficient amount of water.
- DOLOSCOP can be used in children older than 10 years, if necessary.

Suppositories:

One suppository, three times daily.

Overdose:**Symptoms:**

- (Hyoscine-N-Butylbromide): In case of overdose, anticholinergic effects are observed (e.g. urinary retention, dry mouth, flushing of the skin, tachycardia, inhibition of gastrointestinal motility, visual disturbances).

- Symptoms of a Paracetamol overdose usually appear within the first 24 hours and include pallor, nausea, vomiting, loss of appetite, and abdominal pain. Paracetamol overdose may cause hepatic cytolysis which can lead to hepatocellular failure, gastrointestinal bleeding, metabolic acidosis, encephalopathy, coma and death.

Treatment:

- (Hyoscine-N-Butylbromide): Symptoms of overdose respond to parasympathomimetics. Cardiovascular complications should be treated according to the usual clinical principles. In the event of respiratory paralysis, intubation and artificial respiration should be considered. In the event of an overdose in patients with glaucoma, pilocarpine should be given. In addition, appropriate supportive measures should be used in each case.

- Paracetamol: If a Paracetamol overdose is suspected, N-acetyl cysteine should be administered intravenously within the first 10 hours (it can be effective for up to 48 hours) after the overdose. Plasma Paracetamol concentration can be reduced by hemodialysis.

Storage:

Keep out of reach of children. Store in a dry place, at a temperature below 25 °C.

Packaging:

Capsules: Each DOLOSCOP carton box contains 10 or 20 Capsules in one or two blister strips.

Suppositories: Each DOLOSCOP carton box contains 10 Suppositories in two PVC/PE strips.

- A medication is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
- Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacies



دولوسكوب كيسول و تحاميل

التركيب:

الكيسول: كل كبسولة دولوسكوب تحتوي على: هويسين- ن- بوتيل بروميد ١٠ ملغ وباراسيتامول ٤٠٠ ملغ.
التحاميل: كل تحميلة دولوسكوب تحتوي على: هويسين- ن- بوتيل بروميد ١٠ ملغ وباراسيتامول ٥٠٠ ملغ.
آلية التأثير:

يمارس هويسين- ن- بوتيل بروميد تأثيراً مضاداً للتشنج على العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، الفواق الصفراوية والمساك البولية التاسلية تعود التأثيرات المضادة للتشنج للعضلات الحظيطة إلى حصر العقدة داخل الجدار الحشوي وإلى التأثيرات الكولينية للمساكين.

الباراسيتامول هو مسكن ألم فعال وخافض للحرارة. يعمل عن طريق تثبيط اصطناع البروستاغلاندينات في الجهاز العصبي المركزي وإلى حد أقل من خلال التأثير الحظيطة عن طريق منع توليد نضبات الألم.

الحركة الذاتية:

هويسين- ن- بوتيل بروميد: هو مركب رباعي الأمونيوم، ولذلك فهو قطبي للغاية وبالتالي من خصائصه بشكل جزئي فقد بعد إعطائه عن طريق الفم (٨٪) أو المستقيم (٣٪) يصل إلى التركيز الأعظمي في البلازما خلال ٢٠-٣٠ ساعة. تبلغ نسبة ارتباطه ببروتين البلازما (الالبومين) حوالي ٤٤٪. يتم استقلابه بشكل رئيسي عن طريق التحطيم الحزني لرابطة الإستر، ويخرج في البراز والبول. يُمتص الباراسيتامول بسرعة وبشكل كامل تقريباً في الأمعاء البقية. بعد الإعطاء الفموي، يتم الوصول إلى التركيز الأعظمي في البلازما بعد الإعطاء الفموي خلال ٢٠-٣٠ ساعة بعد الإعطاء عن طريق المستقيم يُمتص الباراسيتامول محطياً توأفاً حيويًا ٣٠ إلى ٤٠٪. يتم الوصول إلى التركيز الأعظمي في البلازما بعد الإعطاء خلال ١,٣-٣,٥ ساعة. ينتشر الباراسيتامول بسرعة في جميع الأنسجة. الارتباط ببروتينات البلازما يكون منخفض بين (٥-٣٠) ٪. يستقلب الباراسيتامول بشكل رئيسي في الكبد، ويبلغ العمر النصفى لإطرحة ما يقارب الساعتين.

الاستجابات: يستقبل دولوسكوب لدى المرضى الذين يعانون من تشنجات في الجهاز الهضمي، الأتقية الصفراوية، المساك البولية التاسلية (مثل عسر الطمث لدى الإناث).

مضادات الاستجابة:
- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو تجاه أي من مكونات المستحضر.
- تضيق ميكانيكي في الجهاز المعدي المعوي.

- تضخم القولون.
- احتباس البول بالانسداد تحت المثانة (مثل ورم غدي في البروستات).
- الزرق ضيق الزاوية.
- تسرع القلب.
- الوهن العضلي الوبيل.

التحذيرات والأخطائات:
- في حال استمر الألم الشديد في البطن أو تفاقم أو ترافق مع أعراض أخرى مثل الحمى، الغثيان، الإقياء، تغيرات في حركة الأمعاء، انخفاض ضغط الدم، إغشاء، وجود دم في البراز، يجب استشارة الطبيب على الفور.
- يجب استخدام دولوسكوب بحذر لدى المرضى الذين يعانون من:
● خلل الوظيفة الكبدية (بسبب تعاطي الكحول المزمن أو التهاب الكبد).
● عوز في إنزيم غلوكوز-٦- فوسفات ديهيدروجيناز.
● يجب مراقبة تعداد الدم، الوظيفة الكبدية والكلوية عند الاستخدام المطول.

الحمل والإرضاع:
الحمل: لا توجد بيانات كافية عن استخدام دولوسكوب خلال فترة الحمل، يجب عدم استخدام دولوسكوب دون استشارة الطبيب.
الإرضاع: بالنسبة لـ هويسين- ن- بوتيل بروميد، لم يتم إثبات أمان استخدامه خلال فترة الإرضاع. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أية آثار ضارة على الرضيع. يُقرز الباراسيتامول في حليب الثدي، لكن من غير المحتمل أن يؤثر على الرضيع عند استخدامه بالجرعات العلاجية.

القيادة واستخدام الآلات:
لم يتم إجراء أي دراسات حول التأثيرات على القدرة على القيادة أو استخدام الآلات، يجب توخي الحذر عند المرضى الذين يعانون من اضطرابات بصرية.

التداخلات الدوائية:
- من الممكن أن يؤدي الاستخدام المتزامن مع مضادات الكولين، أماتانيدن، مضادات الأذنان ثلاثية الحلقة ورباعية الحلقة، الفصائل الكينيدون، مضادات الهيستامين، ديسوبيراميد بالإضافة إلى التأثير الممبب تسرع القلب

لمحاكيات الودي β إلى زيادة التأثيرات المضادة للفعل الكوليني.
- يمكن أن يؤدي الاستخدام المتزامن مع حاصرات الدوبامين مثل ميتوكلوراميد إلى إضعاف مشترك في التأثير على حركة الجهاز المعدي المعوي.

- يؤدي الاستخدام المتزامن مع بروبرينسود إلى انخفاض تصفية الباراسيتامول، لذلك يجب تخفيض جرعة الباراسيتامول.

- قد يؤدي الاستخدام المتزامن لفرقات طويلة مع مضادات التخثر مثل الوارفارين والكراميرات الأخرى إلى تعزيز التأثير المضاد للتخثر وبالتالي زيادة خطر حدوث نزف.

- يجب توخي الحذر عند الاستخدام المتزامن مع فلوكلوكساسولين بسبب احتمالية حدوث حمض استقلابي.

التأثيرات الجانبية:
تعود معظم الآثار الجانبية المعروفة إلى الخصائص المضادة للفعل الكوليني لهويسين- ن- بوتيل بروميد. تكون هذه الآثار المضادة للفعل الكوليني خفيفة بشكل عام، مثل: دوام، تعب، جفاف الفم (تنشيط إفراز اللعاب)، إسهال، غثيان، إقياء، انزعاج في المعدة، ضيق تنفس.

وبشكل نادر: انخفاض ضغط الدم، احمرار الجلد، عدم انتظام ضربات القلب، احتباس البول.

الجرعة والاستعمال:

الكيسول:

- البالغون: كبسولة واحدة أو كبسولتان، ثلاث مرات في اليوم.
- يجب ألا تتجاوز الجرعة اليومية الإجمالية ٦ كبسولات.

- يجب عدم مضغ الكبسولات، بل يجب ابتلاعها بشكل كامل مع كمية كافية من الماء.

- من الممكن استخدام دولوسكوب لدى الأطفال الأكبر من ١٠ سنوات، إذا لزم الأمر.

التحاميل:

تصميلة واحدة، ثلاث مرات يومياً.

فرط الجرعة:

الأعراض:

(هويسين- ن- بوتيل بروميد): في حالة الجرعة الزائدة، تلاحظ التأثيرات المضادة للكولين (مثل احتباس البول، جفاف الفم، احمرار الجلد، تسرع القلب، تنشيط الحركة المعوية، اضطرابات بصرية).

تظهر أعراض الجرعة الزائدة من الباراسيتامول عادةً خلال ٢٤ ساعة الأولى وتشمل الشحوب، الغثيان، القيء، فقدان الشهية، آلام البطن. قد تؤدي الجرعة الزائدة من الباراسيتامول إلى انحلال خلوي كبدي يمكن أن يؤدي إلى قصور في الخلايا الكبدية، نزيف معدي معوي، حمض استقلابي، اعتلال دماغي، غيبوبة، وموت.

العلاج:

(هويسين- ن- بوتيل بروميد): تستجيب أعراض فرط الجرعة لمحاكيات نظير الودي. يجب معالجة مضاعفات القلب والأوعية الدموية وفقاً للمبادئ العلاجية المعتادة. في حال الشلل التنفسي يجب مراعاة إجراء التنبيب والتنفث الاصطناعي.

في حال حدوث الزائدة لدى مرضى الغلوكوما يجب إعطاء البيلوكاربين. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام الأدوية الداعمة المناسبة حسب كل حالة.

باراسيتامول: في حال الاشتباه بتناول جرعة زائدة من الباراسيتامول، يجب إعطاء - ن- أسيتيل سيستئين حقناً وريئياً خلال الـ ١٠ ساعات الأولى (يمكن أن يكون فعالاً لمدة ٤٨ ساعة) من تناول الجرعة الزائدة. يمكن تقليل تركيز الباراسيتامول في البلازما عن طريق غسيل الكلى.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في مكان جاف، بدرجة حرارة أقل من ٢٥ °م.

التعبئة:

الكيسول: كل عبوة كرتونية دولوسكوب كيسول تحتوي على ١٠ و ٢٠ كبسولة ضمن شريط أو شريطين بليستر.

التحاميل: كل عبوة كرتونية دولوسكوب تحاميل تحتوي على ١٠ تحاميل ضمن شريطين PVC/PE.

الدواء مستحضر بوزل على شكل حبة، وإضافة خلاصة التمارين بحركه الطير (التي تعطي ريشة الطائر)، وفي حالة الإصابة بالتهاب في عضلات الرقبة (تشنج العضلات) يمكن استخدامها. يمكن استخدامها في حالة الإصابة بالتهاب في عضلات الرقبة (تشنج العضلات) يمكن استخدامها. يمكن استخدامها في حالة الإصابة بالتهاب في عضلات الرقبة (تشنج العضلات) يمكن استخدامها.

إنتاج شركة ريشة للأنظمة الدوائية - سوريا